

第4場_衛教資源清單與內容大綱

處方藥可近性試辦計畫 | 衛教資源清單與各清單內容大綱（草案） 整理：2026-07-17 依據：第 2 場浮現之衛教方向 + 第 3 場《藥局供應ECP評估與轉介流程表》各情境衛教清單 · 用途：第 4 場會議（第 11 章 衛教資源）提出討論 設計原則：①「先衛教、後交付」（2016 配套既定）；②系統依填答自動帶出個人化衛教清單，藥師逐項勾選確認、未完成不可結案；③定位「補救 ≠ 常規」、常規避孕優先；④文字需淺顯易懂；⑤對外素材以「生殖健康」為主軸、與性教育及性病防治整合。

一、衛教資源清單（試辦計畫須產製之衛教素材）

分兩類：**A 交付端**（藥師給藥當下逐項執行，對應個人化衛教清單） / **B 對外端**（面向民眾與社會之宣導）。各清單詳細內容見「二、」。

編號	素材名稱	形式	對應
A. 交付端 (藥師逐項執行)			
A1	基礎衛教單（給藥必附；含服藥後警訊圖示——子宮外孕 / 嘔吐補服 / 驗孕時點；併肝酵素誘導劑之交互作用告知）	紙本單張 + 系統電子版	●● 全員；含基礎清單 1-7
A2	情境判斷流程卡（藥師評估用；濃縮流程表 ①禁忌→②懷孕→③出血→④時效→⑤身分→⑥轉介之紅黃綠分流步驟）	藥師端卡片 / 系統提示	全情境，供藥師快速判斷分流、對應處置與衛教清單
A3	加值衛教（系統依情境自動加掛於基礎衛教單；內容大綱見「二、」）	系統電子版 / 單張加頁	● 各情境
A3-1	疑似性暴力 / 性侵害衛教	系統加掛	● -1 (●-1)
A3-2	性傳染病風險衛教	系統加掛	● -2 (●-2)
A3-3	短期重複使用衛教（強化常規避孕 / LARC）	系統加掛	● -3 (●-3)
A3-4	哺乳中衛教	系統加掛	● -4 (●-4)
A3-5	非通報之社會風險（社福資源）衛教	系統加掛	● -5 (●-6)
A3-6	就醫指引衛教單（轉介事由、就醫時效急迫性〔UPA≤120h / 含銅 IUD≤5 日〕、就醫會經歷什麼；附轉介單）	系統隨轉介產生	● 不供藥轉介 / ● 醫療轉介
B. 對外端 (社會宣導)			

編號	素材名稱	形式	對應
B1	「補救 ≠ 常規」宣導（生殖健康主軸、常規優先）	社群圖文	對外
B2	「延遲排卵 ≠ 墮胎」釐清素材	圖文	對外，針對「誤認墮胎藥」認知

說明：A3-1~A3-5 為系統依填答自動加掛於基礎衛教單之加值項目（肝酵素誘導劑之交互作用告知已併入 A1、不另立加值單），；A3-6 就醫指引衛教單供 ● 不供藥轉介 / ● 醫療轉介之個案，由系統隨轉介單產生。內容大綱見「二、」；社福資源 QR Code 由資訊系統隨清單產生，不另列為獨立素材。

二、各衛教清單內容大綱（系統依情境自動帶出）

「基礎清單」= 下列基礎 1-7 項，● 全員必做。系統於基礎清單上自動加掛各 ● 情境之加值項目；● / ● 不供藥者改帶「就醫指引 / 替代途徑」。與《藥局供應 ECP 評估與轉介流程表》第八節一致。

● 基礎衛教清單（全員必做・對應素材 A1 基礎衛教單）

1. 盡速服用：越早效果越好；不強制當場服用，願意者可當場服。
2. 嘔吐補服：服藥後短時間內（約 2-3 小時）嘔吐須補服一劑。
3. 常見副作用：月經提前 / 延後、點狀出血、噁心、頭痛（多為短暫）。
4. 警訊衛教（子宮外孕把關）：月經延遲逾 1 週應驗孕；服藥後約 3 週建議驗孕或回診確認避孕成功；出現下腹劇痛或異常出血應立即就醫（子宮外孕警訊，發生率約萬分之一，惟延誤危險）。
5. 補救 ≠ 常規：緊急避孕為補救措施、非常規避孕；提供常規避孕與雙重避孕（常規避孕 + 保險套）之衛教及銜接方式。
6. 肝酵素誘導劑交互作用告知（服用抗癲癇藥、聖約翰草等者）：告知此類藥物會使 LNG 效果可能下降；加強後續避孕、建議諮詢醫師 / 藥師。（併入基礎衛教單 A1，不另設加值單）
7. 社福與諮詢資源：衛教單附社福資源與相關諮詢 QR Code。

● ● ● 加值衛教清單（● 於基礎清單上加掛；● 以就醫指引取代；● 改為替代途徑告知）

情境	加掛內容大綱
A3-1 ● -1 疑似性暴力 / 性侵害 (6-1)	①113 通報與一站式服務流程說明——就醫會經歷什麼、社工陪同、避免重複陳述；②保留證據提醒——勿盥洗 / 換洗衣物、儘速就醫採證；③心理支持資源——性侵害防治中心、心理諮商專線。

情境	加掛內容大綱
A3-2 ● -2 性傳染病風險 (6-2)	①性病篩檢衛教——建議至婦產科篩檢項目、空窗期 (window period) 概念； ②保險套正確使用；③伴侶篩檢與告知建議。
A3-3 ● -3 短期重複使用 (6-3)	①強化常規避孕衛教——LARC (長效可逆避孕) 等選項比較、轉介婦產科避孕諮詢；②月經紊亂預期說明——重複使用月經易亂、無嚴重安全疑慮；③追蹤說明——納入服藥者追蹤。
A3-4 ● -4 哺乳中 (6-4)	哺乳衛教——已查證國內 LNG 仿單無「暫停 24h」→ 依國際「可繼續哺乳」(FSRH / WHO 認 LNG 後無須中斷哺乳)；衛教「服藥前先哺乳、避免服後馬上哺乳」。
A3-5 ● -5 非通報之社會 風險個案 (6-6)	在 A1 基礎社福 QR 之上，藥師主動逐項說明資源內容並鼓勵自主聯繫 (不強制轉介、不追蹤)。逐項說明內容 (草案，具體單位 / 專線由計畫團隊彙整)： ①113 保護專線 (家暴 / 性侵 / 兒少保護求助)；②未成年懷孕求助 (民間機構如勵馨等)；③各縣市社會局家庭福利服務中心 (經濟弱勢 / 單親 / 婦幼福利)；④性侵害 / 性騷擾防治中心；⑤心理支持 (1925 安心專線、心理諮商)； ⑥生育保健 / 家庭計畫諮詢 (避孕與優生保健)。
A3-6 ● 不 供藥、直接轉 介 / ● 醫療 轉介 (就醫指 引衛教單)	①轉介事由說明；②就醫時效急迫性 (UPA $\leq$ 120 小時 / 含銅子宮內避孕器 $\leq$ 5 日)；③就醫會經歷什麼；④系統產生轉介單。● 者無供藥衛教、以本單取代；● 醫療轉介者於基礎 + 加值衛教外另附本單。
● 不符本人 親領 (代購 / 身分不符)	替代途徑告知——現行就醫程序、時效急迫性；系統記錄已告知時間。

三、待第 4 場確認事項

1. 交付端形式 (情境判斷流程卡 A2 / 書面基礎衛教單 A1 / 系統電子版) 是否皆須標準化、以何者為主？(連動第 6 章給藥流程)
2. 衛教範圍界線：要不要把 性傳染病 (STI) 篩檢、長效可逆避孕 (LARC) 從「加值 (情境限定)」升級到基礎清單 (全員必做)？(雙重避孕已在基礎清單；第 11 章 §11.1 待決)